

Resumo Clínico — Lesão do Tornozelo Direito

Paciente: Lúdia Gameiro Henriques de Sousa **Morada:** Estrada Principal, n.º 15, 2490-792 Favacal **Data de elaboração:** 17 de junho de 2026

Nota importante: Este documento foi organizado pela família a partir dos relatórios e da informação disponíveis. **Não é um diagnóstico médico** — serve para reunir, num só lugar, o histórico dos exames, o diagnóstico final do ortopedista e o plano de tratamento.

Diagnóstico final (ortopedista)

Fratura do maléolo externo do tornozelo direito (a ponta inferior do perónio). Tratamento conservador — sem cirurgia.

Cronologia dos exames

Data	Exame	Resultado
15/05/2026	Raio X	Sem fratura visível — "tudo bem"
25/05/2026	Raio X	Novamente sem alterações — "tudo bem"
26/05/2026	Ecografia do tornozelo direito (NDE — Dr. Victor Pardal)	Lesão de ligamento com derrame articular
(início de junho)	Avaliação do fisioterapeuta	Suspeita de "fissura"
17/06/2026	Raio X + consulta de Ortopedia	Fratura do maléolo externo confirmada

Resumo de cada exame

Raios X — 15/05 e 25/05

Duas radiografias sem fratura visível. Algumas fraturas finas do maléolo **não se veem nas primeiras radiografias**, tornando-se evidentes só mais tarde — o que explica a deteção posterior.

Ecografia do tornozelo direito — 26/05 (Dr. Victor Pardal, Céd. Prof. 35364)

Lesão dos tecidos moles, coerente com a fratura do lado de fora do tornozelo:

- **Provável rutura parcial do ligamento perónio-astragalino anterior**, com tecido de granulação (cicatrização em curso).
- **Derrame moderado** dentro da articulação, com possível conteúdo hemático, e provável **lesão da cápsula**.
- **Ligamento deltoide e tendões tíbio-peroniais íntegros**.
- **Edema moderado** na metade inferior da perna e à volta do tornozelo.

Raio X + Ortopedia — 17/06

Confirmou **fratura do maléolo externo** (perónio). O maléolo externo é a ponta inferior do perónio, pelo que a suspeita inicial de "fratura no perónio" estava correta.

Plano de tratamento (ortopedista)

- **Sem esforços nem cargas durante 6 semanas** — não pôr peso nem fazer força com o pé.
 - **Mobilizar o tornozelo com suavidade** durante esse período, para evitar rigidez.
 - **Manter a ligadura mais ~1 semana** e depois ir retirando gradualmente.
 - **Bota já não é necessária** (fratura considerada estável).
 - **8 sessões de fisioterapia** para recuperar mobilidade, força e equilíbrio.
-

A confirmar com o fisioterapeuta / médico de seguimento

1. Pode pousar o pé e andar um pouco, ou deve evitar pôr peso (eventualmente com canadianas)?
 2. Está prevista uma **radiografia de controlo** ao fim das 6 semanas para confirmar a consolidação antes de voltar à carga total?
 3. Que sinais de alarme devem motivar regresso ao médico (dor intensa, inchaço a aumentar, deformação)?
-

Cuidados gerais durante a recuperação

- Cumprir as 6 semanas sem carga, mesmo que o pé pareça melhor.
- Elevar o pé e aplicar gelo se houver dor ou inchaço.
- Fazer os movimentos suaves indicados, sem forçar.

- Boa alimentação, vitamina D/cálcio se necessário, não fumar (o tabaco atrasa a consolidação óssea).
 - Cumprir as sessões de fisioterapia e progredir a atividade de forma gradual.
-

Documento de apoio. Toda a interpretação e decisão clínica cabem ao médico.